



GABYNEUROPEDIA

Checklist de Observación Diferencial TDAH

Escala Completa de 24 Puntos

Herramienta de Tamizaje Parental para Neurodesarrollo Infantil



DISCLAIMER MÉDICO IMPORTANTE

Este checklist es una herramienta informativa diseñada exclusivamente con fines educativos. NO constituye un diagnóstico médico. El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) requiere una evaluación presencial formal realizada por un neuropediatra, psiquiatra infantil o neuropsicólogo cualificado.

Consulte siempre a un especialista en neurodesarrollo antes de tomar cualquier decisión terapéutica.

Desarrollado por **Dra. María Gabriela Jiménez Méndez**
Neuropediatra · Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona



Instrucciones de Uso

Lee cada enunciado cuidadosamente y marca con una ✓ aquellos que describan conductas **frecuentes y consistentes** que observas en tu hijo/a. No te alarmes si marcas varios ítems; este ejercicio te ayudará a organizar tus observaciones para compartirlas de forma objetiva con tu pediatra.

SECCIÓN A: MARCADORES CONDUCTUALES DEL TDAH (8 ítems)

- ☐ b1. Se distrae con mucha facilidad ante estímulos irrelevantes y suele extraviar objetos de uso diario.

La inatención es un rasgo central del espectro del TDAH, pero también se ve alterada por fatiga visual, privación de sueño o estrés emocional.

- ☐ b2. Se le hace difícil permanecer sentado y suele retorcerse en el asiento o mover constantemente las manos de forma inquieta.

La hiperactividad física se debe a una necesidad de autorregulación del cerebro, pero también aparece ante fatiga crónica o aburrimiento severo.

- ☐ b3. Suele responder de forma precipitada antes de que se complete la pregunta o interrumpe bruscamente actividades de otros.

La impulsividad es un marcador común en el neurodesarrollo. Requiere evaluar si es generalizada o si responde a problemas de gestión emocional.

- ☐ b4. Dificultad para planificar tareas secuenciales o necesita que se le organicen los pasos antes de comenzar.

La disfunción ejecutiva en planificación es un marcador central del TDAH. Los niños saben "qué" hacer pero no "cómo" organizar el orden de las acciones.

- ☐ b5. Procrastinación crónica o "paralización" ante tareas con múltiples pasos.

El trastorno de inicio de tareas relacionado con sobrecarga de memoria de trabajo es distintivo del TDAH, diferente de la simple pereza.

- ☐ **b6. Olvida constantemente dónde puso sus pertenencias (mochila, juguetes, útiles escolares).**

La dificultad con la constancia de objeto y memoria de trabajo visuo-espacial es común en TDAH pero también aparece con estrés o falta de rutinas.

- ☐ **b7. Se queda "paralizado" ante múltiples opciones o toma decisiones de forma muy lenta.**

La sobrecarga ejecutiva ante decisiones es característica del TDAH. El cerebro se "congela" cuando hay demasiadas variables que procesar simultáneamente.

- ☐ **b8. Rendimiento altamente inconsistente: puede hacer algo perfectamente un día pero no lograrlo al día siguiente.**

La inconsistencia de desempeño es un sello distintivo del TDAH, diferenciándolo de déficits de capacidad real. "A veces puede" es clave diagnóstica.

SECCIÓN B: FACTORES DIFERENCIALES AMBIENTALES (8 ítems)

- ☐ d1. Tiene hábitos de sueño irregulares o duerme constantemente menos de 9-10 horas por noche.

La privación o fragmentación de sueño imita de forma idéntica la inatención y la baja tolerancia a la frustración (síndrome de pseudo-TDAH).

- ☐ d2. Supera regularmente las 1.5 a 2 horas diarias de pantallas (celular, tablet, videojuegos).

La sobreestimulación dopaminérgica de las pantallas altera los circuitos de gratificación a largo plazo, imitando el déficit atencional cuando están apagadas.

- ☐ d3. Se muestra ansioso, le preocupan mucho las cosas de forma recurrente, o tiene rasgos perfeccionistas exagerados.

Los trastornos de ansiedad infantiles a menudo se manifiestan como inquietud motora y distracción, confundiéndose fácilmente con hiperactividad.

- ☐ d4. Estrés crónico en los cuidadores, dinámicas familiares tensas o conflictos parentales frecuentes.

El estrés ambiental familiar mimetiza síntomas de TDAH. Los niños reflejan la desregulación emocional de sus cuidadores principales.

- ☐ d5. Cambios recientes significativos: mudanza, cambio de colegio, separación familiar, duelo o pérdida.

El duelo, trauma y estrés de adaptación generan disociación e inatención que pueden confundirse fácilmente con TDAH primario.

- ☐ d6. Consumo frecuente de bebidas o alimentos con alto contenido de azúcar, colorantes artificiales o procesados.

Los estimulantes dietéticos desregulan la dopamina de forma similar al TDAH. La hipoglucemia reactiva imita inatención e irritabilidad.

☐ **d7. Problemas visuales no corregidos (miopía, astigmatismo) o pérdida auditiva parcial no diagnosticada.**

Los déficits sensoriales sin corregir son malinterpretados como distracción. El niño no ve/oye bien y aparenta estar "en su mundo".

☐ **d8. Enfermedad crónica, medicaciones regulares o recuperación reciente de infección/cirugía.**

Los estresores fisiológicos y efectos secundarios de medicamentos mimetizan perfectamente síntomas de TDAH sin serlo.

SECCIÓN C: MARCADORES SOCIOEMOCIONALES (8 ítems)

- ☐ e1. Explota con rabietas intensas ante la frustración rutinaria y tarda más de lo habitual en calmarse.

La desregulación emocional es común en niños con TDAH debido a la inmadurez de las funciones ejecutivas, pero también acompaña al duelo o estrés.

- ☐ e2. Suele rechazar o resistirse fuertemente a realizar tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido.

La evitación de tareas puede ser señal de una disfunción ejecutiva para planificar/comenzar, o de un bloqueo ante el miedo a fracasar.

- ☐ e3. Dificultades sociales marcadas: es rechazado por compañeros, evita interacciones o sufre bullying.

El rechazo social genera desregulación emocional y "acting out" conductual que se confunde con impulsividad del TDAH.

- ☐ e4. Baja autoestima o autocrítica destructiva constante ("soy malo", "no puedo", "todos me odian").

El "learned helplessness" y vergüenza generan evitación que imita la procrastinación del TDAH. El miedo al fracaso paraliza.

- ☐ e5. Ansiedad por separación o apego ansioso excesivo hacia los cuidadores.

La ansiedad de separación se manifiesta como inquietud motora e incapacidad para concentrarse cuando el cuidador no está visible.

- ☐ e6. Rigidez cognitiva extrema o inflexibilidad ante cambios de rutina (crisis ante imprevistos).

Los rasgos del espectro autista o patrones tipo TOC requieren diagnóstico diferencial. A menudo coexisten con TDAH pero no son lo mismo.

- ☐ **e7. Sensibilidades sensoriales marcadas: rechaza texturas, sonidos, luces brillantes, etiquetas de ropa.**

Los problemas de procesamiento sensorial causan desregulación conductual distinta del TDAH, aunque frecuentemente comórbida.

- ☐ **e8. Comportamientos repetitivos, estereotipados o rituales compulsivos (alinear objetos, tocar repetidamente).**

Indicadores del espectro autista/TOC que requieren evaluación separada. Comunes en presentaciones comórbidas con TDAH.



Interpretación de Resultados

Cuenta cuántos ítems marcaste en cada sección y registra los totales en la tabla siguiente:

Categoría	Ítems Marcados	Interpretación Preliminar
SECCIÓN A Marcadores Conductuales	____/8	Si marcaste 4 o más : Alta presencia de rasgos conductuales típicos de TDAH. Consulta recomendada.
SECCIÓN B Factores Diferenciales	____/8	Si marcaste 3 o más : Factores ambientales/médicos presentes que pueden imitar TDAH. Prioriza corregir estos antes de diagnóstico.
SECCIÓN C Marcadores Socioemocionales	____/8	Si marcaste 3 o más : Componente emocional o comorbilidad presente. Evaluar ansiedad, autoestima y procesamiento sensorial.



CONSULTA PROFESIONAL RECOMENDADA

Si marcaste **4 o más ítems conductuales (Sección A)**, **0 3 o más ítems en cualquier categoría**, es recomendable agendar una evaluación formal con un especialista en neurodesarrollo.

Este checklist **NO reemplaza el diagnóstico profesional**. El TDAH requiere:

- Evaluación clínica presencial completa
- Historial de desarrollo detallado
- Observación en múltiples contextos (hogar + escuela)
- Descarte de factores médicos y ambientales
- Pruebas neuropsicológicas cuando sea necesario

Próximos Pasos Recomendados:

1. **Registra observaciones específicas:** Anota ejemplos concretos de cada conducta marcada (cuándo ocurre, frecuencia, duración).
2. **Comparte con el colegio:** Pide a los maestros que completen este checklist desde su perspectiva.
3. **Agenda consulta especializada:** Contacta a un neuropediatra, psiquiatra infantil o neuropsicólogo.
4. **Revisa factores modificables:** Si marcaste muchos ítems de Sección B, comienza optimizando sueño, pantallas y nutrición.



Próximo Paso Recomendado:

"Sin Filtros! El cerebro de mi hijo no está roto"

El checklist te ayuda a **observar conductas**, pero el ebook te enseña **qué hacer con esa información**. Aprende el **Método C.L.A.R.O.** completo (Calma, Límites, Autonomía, Rutina, Observación) con estrategias científicas explicadas sin tecnicismos por la Dra. Gabriela Jiménez.

Incluye:

- 8 capítulos con protocolos paso a paso
- Hojas de trabajo imprimibles
- Rutinas visuales descargables
- Guías de comunicación con el colegio
- Estrategias de autorregulación emocional



Descargar Ebook "Sin Filtros!" →

[instagram.com/gabyneuropedia](https://www.instagram.com/gabyneuropedia)



Información de Contacto

Dra. María Gabriela Jiménez Méndez

Neuropediatra · Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España

 Email: mariagabrielajimenezmendez@gmail.com

 WhatsApp: +1 (832) 989-0075

 Web: [gabyneuropedia.com](https://www.gabyneuropedia.com)

Redes Sociales:

Instagram: [@gabyneuropedia](https://www.instagram.com/gabyneuropedia)

Facebook: [/gabyneuropedia](https://www.facebook.com/gabyneuropedia)

YouTube: Gaby Neuropedia

LinkedIn: María Gabriela Jiménez

© 2026 GabyNeuroPedia. Todos los derechos reservados.

Este material es de uso educativo e informativo. No constituye consejo médico profesional.

Para diagnóstico y tratamiento, consulte siempre a un especialista cualificado.